

間質性膀胱炎，又叫做膀胱痛症候群（IC/BPS），係一種長期病症，有膀胱或骨盆位置嘅痛楚、壓迫感或不適，同時伴有尿頻或尿急 — 但並非由感染引起嘅。不適感通常喺膀胱愈脹愈明顯，小便後會好返啲。雖然冇單一根治方法，但係可以管理得好。

關於呢個病

IC/BPS 唔係感染，亦唔會傳染。症狀因人而異，通常會有**發作期**（症狀加劇）同較平靜嘅時期。常見特徵：

- 膀胱或骨盆位置有痛楚、壓迫感或不適
- 日夜都有尿頻及／或尿急
- 膀胱愈脹**不適感愈強**，小便後好轉
- 某些食物、壓力或月經周期可能誘發發作

成因

確實成因未明，可能涉及膀胱內壁敏感或受刺激、神經過敏，以及（常見）**緊張或過度活躍嘅盆底肌肉**。由於有多個因素，治療通常要結合幾種方法。

詞彙解釋

IC/BPS

間質性膀胱炎／膀胱痛症候群 — 膀胱痛同尿急，非感染所致。

發作期

症狀加劇嘅時期，常由食物或壓力誘發。

排除性診斷

排除其他原因（如感染）後才確診。

盆底物理治療

放鬆緊張盆底肌肉嘅物理治療。

膀胱灌注

用細尿管將舒緩藥物注入膀胱。

Hunner 病灶

部分患者膀胱壁出現嘅特定病變，可直接治療。

膀胱鏡檢查

用細鏡頭查看膀胱內部。

會唔會好返？ IC/BPS 通常係長期病症，但大多數人透過結合治療、了解誘發因素，都能得到明顯改善。目標係減少發作次數、減輕症狀，令日常生活回復正常 — 通常需要一段時間試驗才搵到最適合你嘅方案，請保持耐心。

點樣診斷

冇單一測試可確診。醫療團隊會根據你嘅症狀，排除其他原因後作出診斷：

- **尿液測試**排除感染或血尿
- 症狀問診同**排尿日記**
- 有時需要做**膀胱鏡檢查**，查看有冇 Hunner 病灶

點樣治療（循序漸進）

- 1 **自我照顧** — 了解**飲食誘因**，管理壓力同睡眠，進行溫和嘅膀胱訓練。
- 2 **盆底物理治療** — 放鬆緊繃肌肉（注意：強力凱格爾運動可能令症狀加劇）。
- 3 **藥物治療** — 口服藥物及舒緩性**膀胱灌注**。
- 4 **針對性及進階治療** — 處理 Hunner 病灶，或頑固個案使用神經刺激療法。

日常照顧

- 常見誘因包括**咖啡、茶、酒精、柑橘類、番茄同辛辣食物** — 試試逐一戒掉再重新加入，找出你自己嘅誘因。
- 準備好**發作應對方案**（休息、熱敷、多飲水、吃溫和食物）。
- 壓力同緊繃嘅盆底肌肉會加劇症狀 — 溫和運動同放鬆練習有幫助。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒、畏寒或背部／側腰痛（可能係感染）
- 新出現嘅**血尿**
- 無法控制嘅發作，或完全排唔到尿

要記住嘅三件事

1. IC/BPS 係膀胱／骨盆痛伴尿急，**並非感染** — 係長期病症，但可以好好管理。
2. 治療結合自我照顧、控制誘因、盆底物理治療、藥物及灌注，以及針對性治療。
3. 了解你嘅飲食同壓力誘因，備妥發作應對方案。新出現嘅血尿、發燒或側腰痛須盡快就醫。